

PREPARE MON CONCOURS

Résumé 16

Couverture Médicale de Base



06 16 03 08 31



valerius-05

ANASS SLIT- INFIRMIER POLYVALENT

INTRODUCTION

«... Il importe également d'élargir la protection sociale et l'assurance maladie, de lutter contre la pauvreté et toute forme d'exclusion, de renforcer la solidarité sociale entre les générations en prenant des mesures urgentes pour sauver les systèmes de retraite avant qu'il ne soit trop tard... »
(Discours du Trône du 30 juillet 2004)

« L'État, les établissements publics et les collectivités territoriales œuvrent à la mobilisation de tous les moyens à disposition pour faciliter l'égal accès des citoyennes et des citoyens aux conditions leur permettant de jouir des droits aux soins de santé, à la protection sociale, à la couverture médicale et à la solidarité mutualiste ou organisée par l'État ». (Article 31 de la Constitution marocaine de 2011)

La politique de développement sociale prônée par **Sa Majesté le Roi Mohammed VI**, que Dieu l'assiste, repose fondamentalement sur la solidarité et cohésion sociale.

L'amélioration du niveau de santé constitue une des composantes essentielles de cette politique qui vise à garantir la pleine participation des citoyens au développement durable du pays.

A cet effet, l'une des priorités de l'État en matière de santé est d'assurer à toute la population l'égalité et l'équité dans l'accès aux soins.

Pour ce faire, **La loi 65-00** portant code de la couverture médicale de base (CMB) constitue le dispositif juridique fondateur de la progressivité de l'universalisation de la couverture maladie au Maroc. La loi consacre le droit des citoyens à la santé et le respect des principes d'équité et d'égalité des citoyens face à l'accès géographique et financier à des services de santé de qualité, compte tenu des ressources disponibles.

D'après les données recueillies auprès de plusieurs acteurs¹¹, à fin septembre 2024, plus de 31,8 millions de personnes étaient enregistrées (immatriculées) auprès d'un régime de couverture

Grâce à la loi n°65-00 portant code de la couverture médicale de base (CMB) et à la création de l'Agence Nationale de l'Assurance d'Assurance Maladie (ANAM) en 2005, le Royaume a mis sur les rails de réformes importantes en matière de Santé. Ces réformes ont permis au Maroc de mettre en place trois régimes de CMB :

- ❖ L'AMO pour les fonctionnaires et retraités du secteur public (AMO public) ;
- ❖ L'AMO pour les salariés et retraités du secteur privé (AMO salarié/privé) ;

Dans la même optique, la première phase de la généralisation de la protection sociale s'est manifestée dans le chantier de la généralisation l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) au cours des années 2021 et 2022. Cette généralisation a pour objectif de couvrir l'ensemble de la population marocaine, par la création de différents régimes de l'AMO. A ce titre, de nombreuses avancées ont été réalisées sur le plan juridique, opérationnel et de gouvernance pour l'ensemble des régimes de l'AMO.

Le financement des prestations de soins de santé est fondé sur les principes de la solidarité et de l'équité, afin de garantir à l'ensemble de la population du Royaume l'accès aux dites prestations.

A cette fin, il est institué un système de couverture médicale, de base comprenant l'assurance maladie obligatoire de base (AMO) et le régime d'assistance médicale (RAMED).

L'assurance maladie obligatoire de base est fondée sur le principe **contributif** et sur celui de la **mutualisation des risques**.

Le régime **d'assistance** médicale est fondé sur le principe de la **solidarité nationale** au profit de la population démunie.

Les personnes assurées dans ce cadre et les bénéficiaires doivent être couverts **sans discrimination** aucune due l'âge, au sexe, la nature de l'activité, au niveau et la nature de leur revenu, leurs antécédents pathologiques ou leurs zones de résidence.

L'assurance maladie obligatoire de base

L'assurance maladie obligatoire de base **s'applique** :

- ❖ Aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des Établissements publics et des personnes morales de droit public
- ❖ Aux personnes assujetties au régime de sécurité sociale en vigueur dans le secteur privé
- ❖ Aux titulaires de pension des deux secteurs publics et privé
- ❖ Aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres personnes exerçant une activité non salariée.

L'assurance maladie obligatoire de base s'applique également, aux anciens résistants et membres de l'armée de libération et aux étudiants de l'enseignement supérieur public et privé.

Les personnes économiquement faibles qui ne sont assujetties à aucun des régimes d'assurance maladie obligatoire de base institués au titre de la présente loi sont éligibles pour la prise en charge des frais de leurs soins, à un régime d'assistance médicale.

La présente loi définit les règles générales communes à l'ensemble des régimes et les règles particulières au régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et des titulaires de pensions des secteurs public et privé, ainsi que les dispositions propres au régime d'assistance médicale.

Les règles régissant les régimes d'assurance maladie obligatoire de base propres aux étudiants, aux travailleurs indépendants, aux personnes exerçant une profession libérale et à toutes autres activités non salariées, seront définies par des législations particulières.

Sont également fixées par une législation particulière les règles et conditions en vertu desquelles les anciens résistants et membres de l'armée de libération peuvent bénéficier du régime d'assurance maladie obligatoire de base dans la mesure où ils n'en bénéficient pas à un autre titre.

✓ Bénéficiaires

Outre la personne assujettie à l'obligation d'assurance maladie de base au titre du régime dont elle relève, l'assurance maladie obligatoire de base couvre les membres de sa famille qui sont à sa charge, à condition qu'ils ne soient pas bénéficiaires à titre personnel d'une assurance de même nature.

Sont considérés comme membres de la famille à charge :

1. Le(s) conjoint(s).
2. Les enfants à charge âgés de 21 ans au plus.
3. Les enfants à charge non mariés âgés de 26 ans au plus et poursuivant des études supérieures.
4. Les enfants handicapés à charge, et ce, sans limites d'âge.

Sont considérés comme personnes à charge sans limite d'âge, les enfants de l'assuré atteints d'un handicap physique ou mental et les enfants pris en charge et qui sont dans l'impossibilité totale, permanente et définitive de se livrer à une activité rémunérée.

L'assuré peut demander l'extension du bénéfice du régime d'assurance maladie obligatoire de base dont il relève à son père et à sa mère, à condition de prendre en charge la cotisation les concernant.

La cotisation des parents est fixée par décret.

Lorsque les parents sont l'un et l'autre assurés en vertu des dispositions de la présente loi, les enfants sont déclarés à l'organisme assureur du père.

En cas de dissolution du mariage, la déclaration doit être faite auprès de l'organisme assureur de l'ex-conjoint auquel la garde des enfants est confiée.

Si la garde des enfants est confiée à une personne autre que la mère ou le père, les enfants conservent le bénéfice du régime d'assurance maladie obligatoire de base de l'un des parents assurés.

Lorsque seul l'un des parents est assuré et en cas de dissolution du mariage, la déclaration est faite auprès de l'organisme assureur de l'ex-conjoint.

✓ Prestations garanties

L'assurance maladie obligatoire de base garantit pour les assurés et les membres de leur famille à charge, quel que soit le régime dont ils relèvent, la couverture des risques et frais de soins de santé inhérents à

- ❖ La maladie
- ❖ L'accident
- ❖ La maternité
- ❖ La réhabilitation physique et fonctionnelle.

Les risques liés aux accidents du travail et maladies professionnelles demeurent régis par la législation et la réglementation les concernant. L'assurance maladie obligatoire de base donne droit, dans les conditions et selon les modalités fixées par voie réglementaire, au remboursement et éventuellement à la prise en charge directe des frais de soins curatifs, préventifs et de réhabilitation médicalement requise par l'état de santé du bénéficiaire

Afférents aux prestations suivantes :

1. Soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'état
2. Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales
3. Soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites
4. Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice
5. Analyses de biologie médicale
6. Radiologie et imagerie médicale
7. Explorations fonctionnelles
8. Médicaments admis au remboursement
9. Poches de sang humain et dérivés sanguins

10. Dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l'accident et du type de dispositifs ou d'implants
11. Appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement
12. Lunetterie médicale
13. Soins bucco-dentaires
14. Orthodontie pour les enfants
15. Actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie
16. Actes paramédicaux

Sont exclues du champ des prestations garanties par l'AMO :

1. Les interventions de chirurgie esthétique
2. Les cures thermales
3. L'acupuncture
4. La mésothérapie
5. La thalassothérapie
6. L'homéopathie
7. Les prestations dispensées dans le cadre de la médecine dite douce

✓ Conditions de remboursement ou de prise en charge

L'assurance maladie obligatoire de base garantit le remboursement ou la prise en charge directe d'une partie des frais de soins par l'organisme gestionnaire de l'assurance maladie obligatoire de base désigné ci-après l'organisme gestionnaire, l'autre partie restant à la charge de l'assuré.

Celui-ci conserve la liberté de souscrire une assurance complémentaire en vue de couvrir les frais restants à sa charge. Toutefois, en cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou en cas de soins particulièrement onéreux, la part restant à la charge de l'assuré fait l'objet d'une exonération totale ou partielle.

La liste des maladies donnant droit à exonération et les conditions dans lesquelles cette exonération est accordée sont fixées par voie réglementaire.

Les taux de couverture et les conditions de remboursement par prestation ou groupes de prestations couvertes sont fixés par la voie réglementaire, sans que ces taux de couverture soient inférieurs aux taux appliqués à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

Certains articles, notamment les appareillages et dispositifs médicaux, font l'objet de remboursement ou de prise en charge sous forme de forfait.

La liste de ces articles, ainsi que les conditions et les limites du forfait sont fixées par voie réglementaire.

Le remboursement ou la prise en charge des frais engagés par les bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base est effectué :

- ❖ L'acte, sur la base des nomenclatures des actes professionnels fixées par l'autorité gouvernementale chargée de la santé
- ❖ Sous forme de forfait par pathologie ou par groupe homogène de maladies
- ❖ Sous forme de dotation globale ou de prépaiement
- ❖ Sous forme de capitation

Dans tous les cas, la facturation des prestations de soins doit être établie suivant les règles définies par voie réglementaire sur proposition de **l'Agence nationale de l'assurance maladie ANAM ou la HAS**.

La tarification nationale de référence pour le remboursement ou la prise en charge des prestations de soins garanties est fixée :

- ❖ Par voie conventionnelle en application du chapitre 2 du présent titre
- ❖ Par voie réglementaire, le cas Échant
- ❖ Pour les médicaments, le tarif national de référence est le prix public des médicaments
- ❖ Pour les appareillages et dispositifs médicaux, les tarifs nationaux de référence sont approuvés par l'administration sur proposition de l'ANAM

Les prestations garanties au titre de l'assurance maladie obligatoire de base ne peuvent être remboursées ou prises en charge que si les soins ont été prescrits et exécutés sur le territoire national.

Toutefois, les prestations dispensées à l'extérieur du territoire national aux bénéficiaires de l'assurance maladie obligatoire de base peuvent être admises, dans les limites fixées par la présente loi et les textes pris pour son application, lorsque le bénéficiaire tombe inopinément malade au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsqu'il ne peut recevoir au Maroc les soins appropriés à son État.

Dans ce dernier cas, le remboursement ou la prise en charge demeure subordonné à l'accord préalable de l'organisme assureur, selon les conditions et modalités fixées par voie réglementaire.

Le bénéficiaire de l'assurance maladie obligatoire de base conserve le libre choix du praticien, de l'établissement de santé, du pharmacien et, le cas échéant, du paramédical et du fournisseur des appareillages et dispositifs médicaux qui lui sont prescrits, sous réserve des mesures de régulation fixées par la présente loi et les textes pris pour son application sur proposition de l'Agence nationale de l'assurance maladie.

Les frais des prestations médicales sont couverts selon le type et la nature de chaque prestation

Soit par voie de prise en charge directe par l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire de base, dans la limite du taux de couverture

Soit par voie d'avance des frais desdites prestations par l'assuré ou le bénéficiaire, à charge pour lui de produire à l'organisme gestionnaire du régime d'assurance maladie obligatoire de base les documents justificatifs et les informations attestant la véracité des soins administrés en vue d'obtenir le remboursement des frais des prestations garanties conformément à la présente loi.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par voie réglementaire

Sont fixés par voie réglementaire :

- ❖ Les modalités de dépôt des documents attestant les frais engagés par l'assuré ainsi que le délai de ce dépôt
- ❖ Le délai maximum pour le remboursement des frais médicaux aux assurés par les organismes gestionnaires, sans toutefois **dépasser trois mois**, ou pour l'obtention de la prise en charge
- ❖ Le délai maximum pour le déboursement au profit du prestataire de soins en cas de tiers-paiement sans, toutefois **dépasser six mois**.

L'inobservation par l'assuré des procédures et réglementations ouvrant droit au remboursement ne fait pas perdre le bénéfice de ce remboursement quand il s'est avéré, dans des conditions fixées par

voie réglementaire, qu'elle est totalement indépendante de la volonté de l'intéressé, en particulier quand elle est due à son état de santé.

**Régime de l'assurance maladie obligatoire de base des salariés et des titulaires de pensions
des secteurs public et privé**

Sont soumis au régime d'assurance maladie obligatoire de base :

- a) Les fonctionnaires, les agents temporaires, occasionnels, journaliers et contractuels de l'Etat, les magistrats, les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires, le corps des administrateurs du ministère de l'intérieur, ainsi que le personnel des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public. Les catégories des agents journaliers sont fixées par voie réglementaire, après consultation des partenaires sociaux.
- b) Les personnes assujetties au régime de sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972), tel qu'il a été modifié et complété
- c) Les personnes titulaires de pensions de retraite, de vieillesse, d'invalidité ou d'ayants cause allouées notamment en vertu des régimes suivants :
 - ✓ Le régime des pensions civiles institué par la loi n° 011-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, en ce qui concerne le personnel civil de l'Etat et des collectivités locales
 - ✓ Le régime des pensions militaires institué par la loi n° 013-71 du 12 kaada 1391 (30 décembre 1971), telle qu'elle a été modifiée et complétée, étendue par le dahir portant loi n° 1-74-92 du 3 chaabane 1395 (12 août 1975) en ce qui concerne les personnels d'encadrement et de rang des Forces auxiliaires
 - ✓ Le régime collectif des allocations de retraite institué par le dahir portant loi n° 1-77-216 du 20 chaoual 1397 (4 octobre 1977), tel qu'il a été modifié et complété
 - ✓ Le régime de la sécurité sociale institué par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15 jourmada II 1392 (27 juillet 1972) susvisé pour les personnels bénéficiaires de pensions de ce régime
- d) Les personnes titulaires de pensions au titre de régimes particuliers de prévoyance sociale autres que ceux cités ci-dessus.

La couverture médicale des corps des Forces armées royales, actifs et titulaires de pensions, ainsi que leurs ayants droit, demeure régie par les dispositions législatives et réglementaires.

1/ Les organismes de gestion :

La gestion du régime d'assurance maladie obligatoire de base est confiée aux organismes :

- I. La Caisse Nationale de Sécurité Sociale**, dénommée ci-après **CNSS**, instituée par le dahir portant loi n° 1-72-184 du 15joudada II 1392 (27 juillet 1972), pour les personnes assujetties au régime de sécurité sociale et leurs ayant droits ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur privé
- II. La Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale**, dénommée ci-après **CNOPS** et, dans les conditions fixées par l'article 83 ci-dessous, les sociétés mutualistes la composant instituées conformément aux dispositions du dahir n° 1-57- 187 du 24 joudada II 1383 (12 novembre 1963) portant statut de la mutualité, pour les fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et des personnes morales de droit public et leurs ayants droit ainsi que pour les titulaires de pensions du secteur public.

La CNSS :

La gestion du régime d'assurance maladie obligatoire de base par la CNSS est autonome par rapport à celle des autres prestations assurées par ladite caisse.

A cet effet, les opérations financières et comptables afférentes font l'objet d'un budget autonome qui comprend :

a) En ressources :

- ✓ Les cotisations salariales
- ✓ Les contributions patronales
- ✓ Les cotisations des titulaires de pensions
- ✓ Le produit financier des placements
- ✓ Le produit des majorations, astreintes et pénalités de retard
- ✓ Les emprunts autorisés conformément à la réglementation en vigueur
- ✓ Les dons et legs acceptés par le conseil d'administration
- ✓ Toutes autres ressources qui peuvent lui être affectées par voie législative ou réglementaire

b) En dépenses :

- ✓ Les paiements et remboursement au titre des prestations garanties par la loi
- ✓ Les contributions aux frais de fonctionnement de l'ANAM
- ✓ Les dépenses de fonctionnement
- ✓ Les dépenses d'investissement
- ✓ Le remboursement des emprunts

Les groupes de prestations couvertes par la CNSS au titre de l'assurance maladie obligatoire de base sont définis comme suit :

En ce qui concerne les maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, **les prestations médicalement requises suivantes :**

1. Les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
2. Les analyses de biologie médicale ;
3. La radiologie et l'imagerie médicale ;
4. Les explorations fonctionnelles ;
5. L'hospitalisation ;
6. Les médicaments admis au remboursement ;
7. Le sang et ses dérivés labiles ;
8. Les soins bucco-dentaires ;
9. Les dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux admis au remboursement ;
10. Les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
11. Les actes paramédicaux ;
12. Les appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement ;
13. La lunetterie médicale.

Les prestations ci-dessus sont couvertes qu'elles soient dispensées à titre ambulatoire ou dans le cadre de l'hospitalisation.

En ce qui concerne l'enfant dont l'âge est inférieur ou égal à 12 ans ;

En ce qui concerne le suivi de la grossesse, l'accouchement et ses suites, les actes médicaux et chirurgicaux tels qu'ils sont définis à la nomenclature générale des actes professionnels et à la nomenclature des actes de biologie médicale ainsi que les médicaments admis au remboursement, le sang et ses dérivés labiles, les actes paramédicaux et, le cas échéant, les actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;

En ce qui concerne l'hospitalisation, l'ensemble des prestations et soins rendus dans ce cadre y compris les actes de chirurgie réparatrice.

Le taux de couverture des groupes de prestations citées à l'article premier ci-dessus est **fixé à 70% de la tarification nationale** de référence, établie conformément à l'article 12 de la loi n° 65-00 susvisée.

Ce taux est porté à **90% pour les maladies graves ou invalidantes** nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, lorsque les prestations y afférentes sont dispensées dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat.

La prise en charge des maladies graves ou invalidantes nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux englobe l'ensemble des prestations médicalement requises par l'état de santé du bénéficiaire y compris la transplantation d'organes et de tissus.

Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale de sécurité sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base est fixé, en ce qui concerne les salariés du secteur privé, à **4%** de l'ensemble des rémunérations visées, réparti à raison de **50%** à la charge de l'employeur et **50%** à la charge du salarié.

Le taux de cotisation fixé à l'alinéa précédent est majoré de **1%** de l'ensemble de la rémunération brute mensuelle du salarié. Cette majoration, due par l'ensemble des employeurs assujettis au régime de sécurité sociale, est à leur charge exclusive.

Le taux de la cotisation due par les marins pêcheurs à la part est fixé à :

- ✓ **1,2%** du montant du produit brut de la vente du poisson pêché sur les chalutiers ;
- ✓ **1,5%** du montant du produit brut de la vente du poisson pêché sur les sardiniers et les palangriers.

Le taux de la cotisation due par les titulaires de pensions est fixé à **4%** sur le montant global des pensions de base servies à condition que ce montant soit égal ou supérieur à **910,00 DH** par mois dans le secteur de l'agriculture et à **1.289,00 DH** par mois dans les autres secteurs.

La cotisation mensuelle due par les personnes bénéficiant d'une assurance volontaire conformément à l'article 5 du dahir portant loi n° 1-72- 184 susvisé est fixée à **4%** du montant de la rémunération mensuelle ayant servi de base au calcul de la dernière cotisation obligatoire au titre de ladite assurance.

La CNOPS :

La CNOPS est chargée en matière d'assurance maladie obligatoire de base de :

- ✓ Instruire, en coordination avec les sociétés mutualistes la composant, les demandes d'affiliation des employeurs et d'immatriculation des personnes relevant de son ressort conformément aux modalités prévues au titre III du livre II de la présente loi
- ✓ Assurer le recouvrement des cotisations salariales et contributions patronales
- ✓ Rembourser ou prendre en charge directement les prestations garanties
- ✓ Conclure les conventions nationales avec les prestataires de soins
- ✓ Établir les comptes relatifs à la gestion de l'assurance maladie obligatoire de base
- ✓ Assurer, en coordination avec les sociétés mutualistes concernées, le contrôle médical

Les groupes de prestations couvertes par **CNOPS** :

1. Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales, actes paramédicaux, de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie délivrés à titre ambulatoire hors médicaments : 80% de la tarification nationale de référence ;
2. Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les actes de chirurgie réparatrice et le sang et ses dérivés labiles : 90% de la tarification nationale de référence. Ce taux est porté à 100% lorsque les prestations sont rendues dans les hôpitaux publics, les établissements publics de santé et les services sanitaires relevant de l'Etat

3. Médicaments admis au remboursement : 70% du prix public Maroc ;
4. Lunetterie médicale, dispositifs médicaux et implants nécessaires aux actes médicaux et chirurgicaux : forfaits fixés dans la tarification nationale de référence ;
5. Appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement : forfaits fixés dans la tarification nationale de référence ;
6. Soins bucco-dentaires : 80% de la tarification nationale de référence ;
7. Orthodontie médicalement requise pour les enfants : forfait fixé dans la tarification nationale de référence ;
8. En cas de maladie grave ou invalidante nécessitant des soins de longue durée ou particulièrement coûteux, l'assuré est exonéré totalement ou partiellement de la part restant à sa charge selon le type de maladies telles que prévues dans la liste arrêtée par le ministre de la santé.
9. La part restant à la charge de l'assuré ne peut être supérieure à 10% de la tarification nationale de référence pour ces maladies.
10. Toutefois, l'exonération de la part restant à la charge de l'assuré est totale pour les soins onéreux.

Le taux de la cotisation due à la Caisse nationale des organismes de prévoyance sociale au titre du régime de l'assurance maladie obligatoire de base est fixé, en ce qui concerne les salariés relevant du secteur public, à **5%** de l'ensemble des rémunérations, réparti à raison de **50%** à la charge de l'employeur et **50%** à la charge du salarié.

Chacune des parts de la cotisation est perçue dans la limite d'un montant mensuel minimum de **70** dirhams et d'un plafond mensuel de **400** dirhams.

Le taux de la cotisation due par les titulaires de pensions est fixé à **2,5%** du montant global des pensions de base servies dans la limite d'un montant mensuel de **70** dirhams et d'un plafond mensuel de **400** dirhams.

Le taux de la cotisation due par les personnes bénéficiant d'une assurance volontaire conformément à l'article 13 du dahir portant loi n° 1- 77-216 susvisé, est fixé à **5%** du montant du dernier salaire mensuel ayant servi de base au calcul des dernières cotisations et contributions au titre de l'affiliation obligatoire au régime collectif d'allocation de retraite.

AMO TADAMON : Régime des personnes n'ayant pas la capacité de s'acquitter des droits de cotisations

La réforme du financement de la santé, initiée en 2002, a permis au Maroc de s'engager vers une CSU organisée autour de trois régimes : un régime contributif permettant l'accès à une assurance maladie obligatoire de base (AMO), destinée à la population active et retraitée des secteurs public et privé, ainsi qu'à leurs ayants droit (AMO public et AMO privé); un régime d'assistance médicale (RAMED) destiné à la population non couverte par l'AMO et ne disposant pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses de santé.

En 2008, une phase pilote d'expérimentation du programme RAMED dans la région de Tadla-Azilal a été lancée. La généralisation du RAMED à l'ensemble du royaume, le 13 mars 2012, a été réalisée suite à une étude de l'évaluation de l'expérience pilote qui a recommandé des améliorations prises en compte, en majorité, dans la préparation à la généralisation.

Selon la loi n° 65-00, le RAMED s'adresse à toutes les personnes qui ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face aux dépenses inhérentes aux prestations médicales.

Ce régime est financé principalement par l'État (75 % des sources de financement), les collectivités territoriales à hauteur de 5 % de financement soit 40Dhs pour chaque personne identifiée en situation de pauvreté et une contribution annuelle des bénéficiaires (20 % de sources de financement) qui sont en situation de vulnérabilité (soit 120Dhs par personne éligible vulnérable avec un plafond de 600 Dhs par ménage).

L'éligibilité au programme RAMED

Il existait deux catégories de bénéficiaires du programme RAMED :

1. Les bénéficiaires par éligibilité :

Sont éligibles au RAMED : les personnes répondants aux deux conditions suivantes :

- Les personnes qui ne sont assujetties à aucun régime d'assurance maladie obligatoire
- Ne disposant pas de ressources suffisantes.

Lorsque la personne est reconnue bénéficiaire, les personnes à sa charge et vivant dans le même foyer sont également couvertes.

Ce sont notamment :

- Le mari et son épouse (s) ou bien la femme chef de foyer
- Leurs enfants à charge, non-salariés, âgés de 21 ans au plus et non couverts par une assurance maladie obligatoire. Cette limite d'âge peut être prorogée jusqu'à 26 ans en cas de poursuite des études dûment justifiée
- Leurs enfants handicapés quel que soit leur âge, qui sont dans l'impossibilité totale et permanente de se livrer à une activité rémunérée par suite d'incapacité physique ou mentale
- Les enfants qui vivent sous le même toit que les personnes bénéficiaires citées ci-dessus, et qui se trouvent à leur charge effective, totale et permanente, sont, à condition d'en apporter la preuve, admis au bénéfice des prestations garanties au titre de l'assistance médicale.

2. Bénéficiaires de droit :

Sont admis de droit au bénéfice du RAMED, en vertu de l'article 118 de la loi n° 65-00 portant code de la couverture médicale de base :

- Les pensionnaires des établissements de bienfaisance, orphelinats, hospices, ou des établissements de rééducation et de tout établissement public ou privé à but non lucratif hébergeant des enfants abandonnés ou adultes sans famille
- Les pensionnaires des établissements pénitentiaires
- La prise en charge de ces personnes est effectuée sur la base de demandes de soins présentées par les directeurs de l'établissement qui les hébergent (voir le Règlement Intérieur des Hôpitaux pour plus d'informations)
- Les personnes sans domicile fixe
- Les personnes qui bénéficient de la gratuité, en vertu d'une législation particulière, pour la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies.

Ces personnes sont éligibles au RAMED dans les conditions suivantes :

- Ils sont dispensés de la procédure d'éligibilité
- Ils ne payent aucune contribution
- Ils ont droit aux mêmes prestations accordées aux bénéficiaires du RAMED par éligibilité.

Également, bénéficient de droit, de la prise en charge d'une ou de plusieurs pathologies, les personnes qui bénéficient de la gratuité en vertu d'une législation particulière, et ce, conformément à l'article 119 de la loi susmentionnée, à savoir :

- Les anciens militaires et anciens combattants (la loi n° 34-97 relative aux anciens militaires et anciens combattants et portant création de la Fondation Hassan II pour les œuvres sociales des anciens militaires et anciens combattants)
- Les Pupilles de la Nation (la loi n° 33-97 relative aux pupilles de la Nation)
- Les malades indigents étrangers (Art unique du Dahir n° 1-61-203 relatif à la prise en charge des frais d'hospitalisation des malades indigents étrangers.)

Panier de soins de RAMED

Ce panier est accessible gratuitement aux bénéficiaires du RAMED à condition de respecter la filière des soins qui doit commencer par le centre de santé de rattachement et éventuellement se terminer par le centre hospitalier universitaire (CHU). L'ensemble des prestations du RAMED sont dispensées uniquement dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'État.

À l'instar de l'AMO, le RAMED bénéficie d'un panier de soins élargi conformément à l'article 121 de la loi n° 65-00. Ce panier couvre, entre autres, les prestations médicales suivantes :

1. Soins préventifs ;
2. Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
3. Soins relatifs au suivi de la grossesse, à l'accouchement et ses suites ;
4. Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales y compris les
5. Actes de chirurgie réparatrice ;
6. Analyses de biologie médicale ;
7. Radiologie et imagerie médicale ;
8. Explorations fonctionnelles ;
9. Médicaments et produits pharmaceutiques administrés pendant les soins ;
10. Poches de sang humain et ses dérivés ;
11. Dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux ;
12. Articles de prothèse et d'orthèse ;

13. Lunetterie médicale ;
14. Soins bucco-dentaires ;
15. Orthodontie pour les enfants ;
16. Actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
17. Actes paramédicaux ;
18. Evacuations sanitaires interhospitalières.

Sont exclus de la couverture garantie par le régime d'assistance médicale les interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l'exception des actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale médicalement requis.

La prise en charge totale ou partielle au titre des prestations citées à l'article 121 ci-dessus ne peut intervenir que pour les maladies et blessures nécessitant l'hospitalisation, des soins ou des examens pratiqués dans les hôpitaux publics, établissements publics de santé et services sanitaires relevant de l'Etat.

Critères d'éligibilité dans le milieu urbain :

1. Le revenu annuel de la personne ne doit **pas dépasser les 5650 DH**, ce qui inclut les transferts et autres revenus perçus par le ménage
2. Le score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables relatives aux conditions de vie du ménage concerné, doit être **inférieur ou égal à 11**

Critères d'éligibilité dans le milieu rural :

1. Le score patrimonial, calculé sur la base de l'ensemble des éléments du patrimoine du ménage, ne doit pas **dépasser 70** par personne composant ce dernier
2. Le score des conditions socio-économiques, calculé sur la base de variables relatives aux conditions de vie du ménage concerné, doit être **inférieur ou égal à 6**

Classification des personnes éligibilités :

Les personnes en situation de vulnérabilité :

1. **Milieu urbain :** Personne dont le revenu pondéré/p/an est supérieur à 3 767 DH par personne et par an et inférieur ou égal à 5 650 DH

2. **Milieu rural :** Personne dont le score patrimonial est supérieur à 28 et inférieur ou égal à 70

Contribution annuelle fixée à 120 DH par personne et par an dans la limite d'un plafond de 600 DH par ménage

Les personnes en situation de pauvreté :

1. **Milieu urbain :** Les personnes dont le revenu pondéré est inférieur ou égal à 3 767 DH/P/an par personne

2. **Milieu rural :** dont le score patrimonial est inférieur ou égal à 28/P

Contribution fixée à 40 DH par personne bénéficiaire et par an

Les demandes sont évaluées sur la base des critères liés aux conditions de vie suivantes :

En milieu urbain

1. Revenu de chaque membre de la famille
2. Nombre de personnes par pièce au sein du foyer
3. Adduction en Eau, Electricité
4. Equipements sanitaires et mode d'évacuation des eaux usées
5. Téléphone
6. Moyens de transport personnels

En milieu rural

1. Terrains agricoles exploités
2. Cheptel
3. Poulailier
4. Matériel agricole et de transport
5. Moyens de transport personnel

6. Equipement téléphonique

7. Equipement sanitaire

La durée de validité de ce récépissé est de trois (3) mois. Passé ce délai, le récépissé n'est plus valable. Le bénéficiaire devra donc se présenter au niveau du service administratif des Caïdats pour récupérer sa carte si sa candidature est retenue.

En fonction du revenu ou du patrimoine calculés et pondérés par le système informatique, deux catégories de bénéficiaires sont distinguées :

Les personnes en situation de pauvreté :

1. Aucune contribution n'est exigée pour le retrait de la carte
2. La durée de validité de la carte est de trois ans.

Les personnes en situation de vulnérabilité

1. La durée de validité de la carte est d'un an
2. Le renouvellement de la carte se fait à l'expiration de chaque année par le paiement d'une contribution annuelle fixée à 120 DH par personne/an dans la limite d'un plafond de 600 DH par ménage quel que soit l'effectif des personnes qui le compose.

Mise en place et évolution du programme

Dans le cadre de la mise en œuvre de la première étape de la réforme de la protection sociale, l'amendement de la loi n°65-00 relative à l'assurance maladie obligatoire de base a donné lieu à la création du régime AMO dédié aux personnes incapables de s'acquitter des droits de cotisation (AMO-TADAMON), en supprimant le Régime d'Assistance Médicales (RAMED). A ce titre, Il convient de mentionner qu'en date du **01/12/2022**, l'ensemble des RAMEDistes disposant de carte Ramed valide au 30/11/2022, ont basculé automatiquement vers AMO-TADAMON.

AMO Tadamon est un régime d'Assurance Maladie Obligatoire de base, géré par la CNSS, destiné aux personnes qui ne peuvent pas s'acquitter des cotisations. C'est l'État qui prend en charge l'intégralité des cotisations pour ces assurés. Ce régime a remplacé l'ancien système RAMED, offrant un panier de soins plus large et un accès aux soins dans les mêmes conditions que les salariés du secteur privé.

Lancé dans le cadre de la réforme de la protection sociale, AMO Tadamon s'inscrit dans la vision royale de généralisation de la couverture médicale. Il couvre aujourd'hui les populations les plus défavorisées identifiées via le Registre Social Unifié (RSU).

Ce régime assurantiel géré par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), couvre plus de 30 % de la population marocaine, soit plus de 11 millions de personnes vivant en situation de vulnérabilité. De plus, il offre aux bénéficiaires, les mêmes prestations garanties au titre des autres régimes contributifs (AMO TNS, AMO Privé et AMO Public).

Dans ce nouveau cadre, l'État prend entièrement en charge :

- ❖ La cotisation des bénéficiaires de l'AMO-TADAMON ;
- ❖ La part restante à la charge de l'assuré (Ticket Modérateur TM), pour les prestations délivrées par les structures publiques de soin, ce qui garantit aux bénéficiaires la gratuité des prestations du secteur public.

Ainsi, le programme permet aux bénéficiaires éligibles de :

- ❖ Bénéficier gratuitement des prestations des établissements publics de santé ;
- ❖ Se faire rembourser sur les frais des médicaments, des analyses médicales... ;
- ❖ Se faire rembourser sur les frais des consultations et prestations médicales effectuées dans le secteur privé ;
- ❖ Bénéficier de la prise en charge des actes médicaux au niveau du secteur privé.

Ce basculement s'est concrétisé en novembre 2022 par l'entrée en vigueur de la loi n° 27-22 modifiant et complétant la loi n° 65-00 relative à l'Assurance Maladie Obligatoire de base, dont les principales dispositions portent sur :

- ❖ La fixation des modalités du basculement automatique des bénéficiaires du RAMED vers le nouveau régime ;
- ❖ Les conditions d'éligibilité au nouveau régime sur la base du Registre Social unifié (RSU) ;
- ❖ La prise en charge par l'État du montant global des cotisations des bénéficiaires ainsi que du ticket modérateur ;
- ❖ L'accès des personnes concernées au même panier de soins à l'instar de leurs homologues dans les secteurs public et privé.

- ❖ Selon le rapport d'activité de l'ANAM, un plan de transfert des activités RAMED à la CNSS a été élaboré par l'ANAM et mis en œuvre en 2022

Le mode de ciblage

Les critères d'éligibilité sont fixés par l'article 116 de la loi n° 65-00 telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 27-22, et le décret n° 2-22-797 du 29 novembre 2022, portant application de la loi n° 65-00 tel qu'il a été complété par le n°2-23-866, l'éligibilité au régime AMO-TADAMON est conditionnée par :

- ❖ L'inscription au Registre Social Unifié (RSU) ;
- ❖ L'incapacité de s'acquitter des droits de cotisation : répondre au seuil d'éligibilité (9.3264284) fixé par l'article 1 du décret n° 2-22-923 ;
- ❖ Le non assujettissement à aucun autre régime AMO, que ce soit en tant qu'assuré principal ou ayant droit.

Le nouveau mécanisme de ciblage RNP/RSU est encadré par la loi n° 72-18 relative au dispositif de ciblage des bénéficiaires des programmes d'appui social et à la création de l'Agence nationale des registres (ANR). Cette loi instaure un dispositif d'identification et de ciblage fiable et transparent basé sur le Registre national de la population (RNP) et le Registre social unifié (RSU).

Le RSU permettra de décider de l'éligibilité des bénéficiaires aux programmes sociaux, en se basant sur leur score économique et social, reflétant leur niveau de vie, et sur un seuil d'éligibilité fixé pour chaque programme.

Intervenants du programme AMO-TADAMON

- ❖ Le ministère de l'Economie et des Finances (Direction du Budget)
- ❖ Le ministère de l'Intérieur (Agence Nationale des Registres)
- ❖ La Caisse Nationale de Sécurité Sociale
- ❖ La Haute Autorité de Santé

Les bénéficiaires couverts par l'AMO-TADAMON

En application des dispositions de l'article 116 de la loi n° 65-00 susmentionnée et son décret d'application n°2-22-797 tel qu'il a été modifié et complété, est considéré comme incapable de

s'acquitter des droits de cotisation toute personne disposant d'un score inférieur au seuil d'éligibilité fixé pour le régime AMO-TADAMON. Les personnes éligibles peuvent bénéficier dudit 35 régime, à condition qu'elles ne soient pas couvertes par d'autres régimes de l'AMO que ce soit en tant qu'assuré principal ou ayant droit.

En plus de l'assuré principal, l'AMO-TADAMON couvre les personnes citées ci-après, comme étant des ayants droit, à condition qu'elles ne soient pas bénéficiaires, à titre personnel, d'un autre régime AMO :

- ❖ Le(s) conjoint(s) ;
- ❖ Les enfants âgés de 21 ans au plus et les enfants pris en charge (en kafala) selon la réglementation en vigueur ;
- ❖ Les enfants âgés de 26 ans au plus, non mariés et poursuivant des études supérieures ;
- ❖ Les enfants en situation de handicap sans limites d'âge, à condition que l'assuré principal soit en vie.

Le panier de soins et la couverture de l'AMO-TADAMON

1. Soins préventifs et curatifs liés aux programmes prioritaires entrant dans le cadre de la politique sanitaire de l'État ;
2. Actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
3. Soins relatifs au suivi de la grossesse, l'accouchement et ses suites ;
4. Soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
5. Analyses de biologie médicale ;
6. Radiologie et imagerie médicale ;
7. Explorations fonctionnelles ;
8. Médicaments admis au remboursement ;
9. Poches de sang humain et dérivés sanguins ;
10. Dispositifs médicaux et implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux compte tenu de la nature de la maladie ou de l'accident et du type de dispositifs ou d'implants
11. Appareils de prothèse et d'orthèse médicales admis au remboursement ;
12. Lunetterie médicale ;

13. Soins bucco-dentaires ;
14. Orthodontie pour les enfants ;
15. Actes de rééducation fonctionnelle et de kinésithérapie ;
16. Actes paramédicaux ;
17. Évacuations sanitaires interhospitalières.

Prestations non couvertes par l'AMO-TADAMON :

Les interventions de chirurgie plastique et esthétique, à l'exception des actes de chirurgie réparatrice et d'orthopédie maxillo-faciale médicalement requis.

Les maladies ALD et ALC : L'ALD « affection de longue durée » se définit comme étant une maladie ou pathologie chronique nécessitant un traitement à vie. Tandis que l'ALC « affection lourde et coûteuse » est une maladie qui nécessite des traitements coûteux, telles que la chirurgie cardiovasculaire ou la transplantation d'organes. Le traitement des ALD/ALC, dont la liste a été fixée par arrêté du ministre de la Santé et qui compte 197 maladies, bénéficie d'un taux de prise en charge qui varie entre 90 % et 100 %. Ainsi, l'assuré est exonéré partiellement ou totalement du coût du traitement. Il existe aussi 252 maladies rares qui ne figurent pas dans la liste susmentionnée, et qui sont exceptionnellement prises en charge par la CNSS.

Taux de remboursement ou de prise en charge :

- ❖ 70 % du Tarif National de Référence (TNR) ;
- ❖ Entre 70 % et 100 %, pour certaines Affections de Longue Durée (ALD) ou Affections Lourdes et Coûteuses (ALC) ;
- ❖ 100 % en cas de prestations médicales dispensées à l'étranger ne pouvant être exécutées au Maroc.

Modalités du bénéfice de l'AMO-TADAMON

Dans le secteur public : Les établissements publics de santé prennent en charge gratuitement l'assuré et ses ayants droit. La personne concernée peut, si elle a acheté des médicaments, effectuer des analyses médicales, des radiographies, ou d'autres prestations médicales, remplir la feuille de soins et joindre les pièces nécessaires pour constituer le dossier de remboursement et le déposer auprès des bureaux de proximité agréés ou des agences CNSS, afin de se faire rembourser.

totale ou partiellement sur les frais de soins engagés. La CNSS rembourse les coûts des prestations de santé fournis par les établissements publics de santé sur la base des données fournies par ces établissements et conformément au cadre de référence déterminé par une convention conclue à cet effet entre la Caisse, l'autorité gouvernementale en charge de la santé et l'autorité gouvernementale en charge du budget.

Dans le secteur privé : L'AMO offre à l'assuré et à ses ayants droit la possibilité de se faire rembourser ou de bénéficier d'une prise en charge totale ou partielle des frais de soins. Ainsi, si l'assuré ou l'un de ses ayants droit se rend à un établissement de soins privé, l'assuré doit présenter son numéro d'immatriculation ou son numéro de CNIE.

AMO ACHAMIL :

Le conseil du gouvernement, réuni, à Rabat sous la présidence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, a approuvé le projet de décret 2.23.690 portant application de la loi 60.22 sur le régime d'Assurance maladie obligatoire de base au profit des personnes capables de s'acquitter de leurs cotisations et n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée. Texte de loi n° 60-22 relatif à l'assurance maladie obligatoire pour les personnes capables de payer les cotisations, publié le 15 juin 2023. Rapport d'activité 2022 de la Caisse nationale de sécurité sociale.

Le dispositif AMO Achamil, lancé progressivement entre 2022 et 2025, incarne la généralisation de la couverture médicale universelle au Maroc. Il cible les 22 millions de Marocains jusque-là hors de toute couverture : non-salariés (artisans, commerçants, agriculteurs, chauffeurs de taxi, indépendants), travailleurs du secteur informel, et personnes vulnérables auparavant couvertes par le RAMED (désormais intégré dans AMO Achamil Tadamon). Gérée par la CNSS via la filiale Tadamon et par l'Agence Nationale de l'Assurance Maladie (ANAM), cette réforme historique a élevé le taux de couverture maladie de 42 % (2020) à plus de 95 % (2025).

Ce guide précise en 2026 : les catégories concernées et les modes d'affiliation (par profession pour les indépendants, par inscription Tadamon pour les personnes à revenus modestes), les cotisations mensuelles (de 0 MAD pour les bénéficiaires Tadamon à 300-500 MAD pour un artisan, selon la catégorie professionnelle), le panier de soins couvert (identique à celui du salarié CNSS), et la procédure en ligne de création de compte via Mon Tadamon ou l'antenne locale CNSS.

Conditions de bénéfice :

- ❖ Le demandeur et ses ayants droit doivent être inscrits au RSU
- ❖ Il doit disposer d'un score supérieur au seuil ouvrant droit à l'AMO Tadamon
- ❖ Il ne doit pas être assujéti à un autre régime d'assurance maladie obligatoire

Population cible :

Est considérée comme capable de payer ses cotisations AMO, toute personne n'exerçant aucune activité rémunérée ou non rémunérée, et dont le score issu du registre social unifié (RSU), dépasse le seuil ouvrant droit à l'AMO Tadamon.

Financement et organisme gestionnaire :

Financement : Les cotisations sont pavées mensuellement. à compter du premier jour de chaque mois, par prélèvement bancaire sur le compte fourni lors de la phase d'inscription sur le portail

Organisme gestionnaire : L'organisme gestionnaire de l'AMO Achamil est la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS). C'est elle qui s'occupe de l'inscription des bénéficiaires. du traitement des demandes et du suivi des cotisations

Le montant de la cotisation est déterminé, en fonction du score obtenu à travers le registre social unifié (RSU), comme suit :

Niveau de notation	Montant de la cotisation mensuelle due en Niveau de notation dhs
Supérieur à 9,3264284 et ne dépasse pas 9,5124369	144 DH
Supérieur à 9,5124369 et ne dépasse pas 9,743001	176 DH
Supérieur à 9,743001 et ne dépasse pas 9,9903727	224 DH
Supérieur à 9,9903727 et ne dépasse pas 10,237316	287 DH
Supérieur à 10,237316 et ne dépasse pas 10,431048	355 DH
Supérieur à 10,431048 et ne dépasse pas 10,739952	454 DH
Supérieur à 10,739952 et ne dépasse pas 11,013068	611 DH
Supérieur à 11,013068	1164 DH

Remboursement

Taux de remboursement ou de prise en charge

1. 70% du tarif national de référence (TNR)
2. Entre 70% et 100%, pour certaines maladies de longue durée (ALD) ou maladies lourdes et coûteuses (ALC)
3. 100% en cas de prestations médicales dispensées à l'étranger ne pouvant être exécutées au Maroc.

Base de remboursement ou de prise en charge des soins : Les frais médicaux sont remboursés ou pris en charge sur la base du tarif national de référence, tandis que le remboursement des frais de médicaments est basé sur le prix public de vente ou sur le prix du médicament générique le plus proche lorsqu'il est disponible.

Délai de dépôt des dossiers de remboursement des soins : Le dossier de remboursement doit être déposé dans un délai légal de 60 jours à compter de la date de la première consultation.

Lieu de dépôt des dossiers de remboursement des soins : Les bureaux de proximité agréés, Les agences CNSS.

Délai légal de remboursement des soins : Trois (3) mois. Toutefois, la CNSS, dans le cadre de l'amélioration en continu de la qualité de ses services s'efforce constamment de réduire ce délai

Moyen disponible pour recevoir le montant remboursé : Le virement sur un compte bancaire déclaré auprès de la CNSS.

AMO Etudiant

Les étudiants éligibles à l'AMOE sont ceux qui ne disposent pas d'une couverture médicale de base soit à titre personnel ou en tant qu'ayant droit d'un assuré (conjoint ou enfants à charge).

Le régime AMO des étudiants, qui a démarré le 13 janvier 2016, est considéré parmi les piliers du système de Couverture Médicale de Base mis en œuvre par notre pays depuis 2005. Il s'adresse à une population d'étudiants ne disposant d'aucune couverture médicale dans d'autres régimes gérés par la CNOPS, la CNSS, la Mutuelle des FAR ni de couvertures transitoires, etc.

Les personnes éligibles à l'AMO des étudiants sont les étudiants et les stagiaires poursuivant :

- ❖ Leur formation dans des établissements de l'enseignement supérieur ou de la formation des cadres relevant d'un département ministériel ou sous sa tutelle, dans le cadre d'un cycle exigeant, pour y accéder, au moins le baccalauréat ou un diplôme équivalent
- ❖ Leurs études dans le cycle terminal de l'enseignement traditionnel
- ❖ Leur formation dans des établissements de l'enseignement public ou privé dans les classes préparatoires pour l'accès aux instituts et écoles supérieurs pour la préparation du diplôme de technicien supérieur
- ❖ Leur formation dans le cycle de technicien spécialisé
- ❖ Leur formation dans un établissement privé de formation professionnelle

Pour bénéficier de ce régime, ces étudiants doivent être régulièrement inscrits dans l'un des établissements mentionnés ci-dessus, être âgés de 30 ans au plus (sauf pour les étudiants relevant du cycle terminal de l'enseignement traditionnel) et ne pas bénéficier d'une couverture médicale en tant qu'assuré ou ayant droit (à la CNOPS ou CNSS, ou chez d'autres mutuelles ou caisses internes).

L'AMO est destinée aux étudiants éligibles et ne concerne pas leurs ayants droit éventuellement (conjoint ou enfants à charge).

Les étudiants assurés ou ayants droit (en tant que conjoints ou enfants) immatriculés à :

- ❖ L'AMO secteur public gérée par la CNOPS,
- ❖ L'AMO -secteur privé ainsi que les autres catégories (TNS-Tadamon) gérées par la CNSS,
- ❖ Des entreprises et établissements assurant une couverture transitoire (article 114) ou aux régimes similaires
- ❖ A la mutuelle des FAR

Ne sont pas éligibles à l'AMO-Etudiants et ils doivent bénéficier des prestations assurées par les régimes susmentionnés jusqu'à **l'âge de 26 ans**.

Panier de soins et taux de couverture

Les étudiants immatriculés à la Caisse Nationale des Organismes de Prévoyance Sociale (CNOPS) bénéficient d'une couverture des risques et des frais de services médicaux résultant d'une maladie, d'un accident, d'une maternité ou d'une réadaptation médicale fonctionnelle ou organique (conformément à l'article 7 de la loi 65-00) :

1. Les soins préventifs et médicaux liés aux programmes prioritaires s'inscrivant dans le cadre de la politique sanitaire de l'État ;
2. Les actes de médecine générale et de spécialités médicales et chirurgicales ;
3. Les soins liés au suivi de la grossesse, à l'accouchement et à ses suites ;
4. Les soins liés à l'hospitalisation et aux interventions chirurgicales, y compris les actes de chirurgie réparatrice ;
5. Les analyses de biologie médicale ;
6. La radiologie médicale et l'imagerie médicale ;
7. Les explorations fonctionnelles ;
8. Les médicaments remboursables ;
9. Le sang humain et ses dérivés ;
10. Les dispositifs médicaux et les implants nécessaires aux différents actes médicaux et chirurgicaux, en tenant compte de la nature de la maladie ou de l'accident et de la qualité de ces dispositifs ;
11. Les appareils de prothèse et d'orthèse médicales remboursables ;
12. L'optique médicale ;
13. Les soins buccodentaires ;
14. La rééducation fonctionnelle et la kinésithérapie ;
15. Les actes paramédicaux.

Exclusions

1. La chirurgie esthétique ;
2. Les cures thermales ;
3. L'acupuncture ;
4. La mésothérapie ;

5. La thalassothérapie ;
6. L'homéopathie ;
7. Les prestations dispensées dans le cadre de ce que l'on appelle la médecine douce (médecine alternative).

Les consultations ou les visites : La Caisse rembourse les consultations ou les visites chez un médecin généraliste ou spécialiste à hauteur de 80% du Tarif National de Référence (TNR). Le médecin doit remplir la feuille de soins en y apposant son cachet, le montant de ses honoraires, et y joindre l'ordonnance médicale.

Analyses de biologie médicale : La Caisse rembourse l'ensemble des analyses biologiques prescrites par le médecin sur la feuille de soins à hauteur de 80% du Tarif National de Référence (TNR). La facture des analyses doit être envoyée ou déposée (sans qu'il soit nécessaire de joindre les résultats des analyses, sauf si le contrôle médical de la Caisse le demande par correspondance personnelle adressée à l'étudiant).

Dispositifs médicaux : Le remboursement des appareils de prothèse et d'orthèse médicale est effectué à hauteur de 100% de la base du montant forfaitaire fixé par arrêté du Ministre de la Santé. Certains de ces dispositifs nécessitent l'obtention d'un « Accord de remboursement » (Prise en charge).

Soins dentaires : La Caisse rembourse les soins et les prothèses dentaires à hauteur de 80% du Tarif National de Référence (TNR) en vigueur.

Optique médicale (Monture et verres) : Le tarif forfaitaire légal est fixé à 800 DH. Le renouvellement des lunettes médicales est possible tous les deux ans, à compter de la date de la dernière prestation.

Kinésithérapie (Rééducation médicale) : La Caisse rembourse les séances de kinésithérapie à hauteur de 80% du Tarif National de Référence, fixé à 50 DH par séance.

Médicaments : La Caisse procède au remboursement des frais des médicaments prescrits sur la feuille de soins selon les conditions suivantes :

- ❖ Le médicament doit figurer sur la liste des médicaments remboursables, consultable sur le site électronique de la CNOPS

- ❖ Le remboursement se fait sur la base du médicament générique s'il est disponible.
- ❖ Le remboursement dépend de l'état de santé de l'assuré :

Pour les soins ordinaires : La Caisse rembourse les médicaments à hauteur de 70% du Prix Public de Vente (PPV).

Pour les assurés atteints d'Affections de Longue Durée (ALD) et maladies coûteuses : La Caisse rembourse les médicaments prescrits pour leur traitement à hauteur de 100% du PPV.

Affections de Longue Durée (ALD) et maladies coûteuses : En cas d'affection de longue durée (voir la liste ci-contre), l'étudiant peut déposer une demande d'exonération totale (100%) de la part restant à sa charge pour les médicaments remboursables liés à cette pathologie.

Affections de Longue Durée (ALD) et maladies coûteuses remboursables ou prises en charge

- 1- Accident vasculaire cérébral ou médullaire ischémique ou hémorragique
- 2- Affections malignes du tissu lymphatique ou hématopoïétique
- 3- Anémies hémolytiques chroniques sévères
- 4- Aplasies médullaires sévères
- 5- Artériopathies chroniques
- 6- Asthme sévère
- 7- Cardiopathies congénitales
- 8- Cirrhoses du foie
- 9- Diabète insulino-dépendant et diabète non insulino-dépendant
- 10- Epilepsie grave
- 11- Etat de déficit mental
- 12- Formes graves des affections neurologiques et neuromusculaires
- 13- Glaucome chronique
- 14- Hypertension artérielle sévère

- 15- Insuffisance cardiaque
- 16- Insuffisance rénale aiguë
- 17- Insuffisance rénale chronique terminale
- 18- Insuffisance respiratoire chronique grave
- 19- Lupus érythémateux aigu disséminé
- 20- Maladie coronaire
- 21- Maladie de Crohn évolutive
- 22- Maladie de Parkinson
- 23- Maladies chroniques actives du foie (hépatites B et C)
- 24- Myélodysplasies sévères
- 25- Néphropathies graves
- 26- Polyarthrite rhumatoïde évolutive grave
- 27- Psychoses
- 28- Rectocolite hémorragique évolutive
- 29- Rétinopathie diabétique
- 30- Sclérodermie généralisée évolutive
- 31- Sclérose en plaques
- 32- Spondylarthrite ankylosante grave
- 33- Syndrome d'immunodéficience acquise (SIDA)
- 34- Syndromes néphrotiques
- 35- Troubles graves de la personnalité
- 36- Troubles héréditaires de l'hémostase

37-Troubles mentaux et/ou de personnalité dus à une lésion. à un dysfonctionnement cérébral ou à une lésion physique

38- Troubles permanents du rythme et de la conductivité

39-Tumeurs malignes

10- Valvulopathies rhumatismales

41- Vascularites

42- Insuffisance hypophysaire

AMO-TNS : Régime des professionnels, des travailleurs indépendants et des personnes non salariées exerçant une activité libérale

L'entrée en vigueur de la loi n°98-15 instituant le régime AMO-TNS

L'adoption de la loi n° 46-23 modifiant et complétant la loi n°98-15, visant à :

- ❖ Prioriser le classement selon les régimes de l'auto-entrepreneur ou de la Contribution Professionnelle Unique (CPU), pour tous les TNS exerçant une seule activité, classés simultanément au titre de la catégorie professionnelle liée l'activité ou à la profession réellement exercée et également à l'un de ces deux régimes;
- ❖ Introduire un délai de carence de 3 mois en cas de régularisation de la situation de l'assuré après une période d'interruption de paiement supérieure à 6 mois;
- ❖ Payer une seule cotisation en cas de double ou multiples activités;
- ❖ Conditionner la délivrance des autorisations relatives à l'exercice d'une profession ou d'une activité par une attestation de régularité de paiement des cotisations au titre de l'AMO-TNS ;
- ❖ Conditionner la recevabilité d'aides et de subventions de l'Etat au profit des personnes physiques et morales soumises au régime AMO-TNS par une attestation de régularité de paiement des cotisations.

Les soins qui sont couverts par l'AMO pour les TNS et leur famille (conjoint et enfants) sont identiques à ceux du régime d'assurance maladie des salariés géré par la CNSS (Voir le site www.cnss.ma), à savoir : les hospitalisations médicales et chirurgicales, et les soins ambulatoires y compris les soins dentaires et optiques.

La cotisation due par chaque assuré du régime d'assurance maladie obligatoire pour les travailleurs non-salariés (AMO-TNS) est déterminée sur la base du revenu forfaitaire applicable à la catégorie, à la sous-catégorie ou au groupe de catégories auquel il appartient. Les modalités de détermination des revenus forfaitaires sont fixées par le décret d'application desdites catégories. Cette cotisation est déterminée seulement pour les personnes soumises au régime de la contribution professionnelle unifiée (CPU) ou au régime de l'auto-entrepreneur, sur la base des droits complémentaires prévus par le Code Général des impôts (l'article 73-II-b-6). La cotisation est calculée sur la base d'un revenu forfaitaire applicable à la catégorie professionnelle de l'assuré. Le taux de cotisation est de **6,37%**.

- Le taux de pauvreté absolue est passé de 15.3% en 2001 à 3% en 2021 (période de pandémie covid-19)
- L'Indice de Développement Humain (IDH) s'est amélioré de près de 30% en passant de 0.541 en 2001 à 0.683 en 2021.
- Il convient de mentionner qu'en date du 01/12/2022, l'ensemble des RAMEDistes disposant de carte Ramed valide au 30/11/2022, ont basculé automatiquement vers AMO-TADAMON. Ce régime assurantiel géré par la Caisse Nationale de la Sécurité Sociale (CNSS), couvre plus de 30 % de la population marocaine, soit plus de 11 million de personnes vivant en situation de vulnérabilité. De plus, il offre aux bénéficiaires, les mêmes prestations garanties au titre des autres régimes contributifs (AMO TNS, AMO Privé et AMO Public).

Historique :

1959 : Mise en place du SNS

1981 : 1^{er} Réforme

1994 : 2^{ème} Réforme

2002 : Adoption la loi 65.00

Aout 2005 : Entrée en vigueur de la CMB

18 Aout 2005 : Démarrage AMO public et privé

13 Mars 2012 : Généralisation du RAMED

13 Janvier 2016 : Démarrage AMO Etudiant

2017 : Adoption la loi 98-15

14 Avril 2021 : Généralisation AMOI

1^{er} Décembre 2022 : Lancé la loi 27-22 : AMO TADAMON

Début Janvier 2024 : Lancé la loi 60.22 : AMO ACHAMIL (Dahir en 25/05/2023)

Définition complète (Assurance Maladie Obligatoire) au Maroc en 2026 couvre désormais **88 %** de la population, soit environ 32 millions de personnes